UN ESPERIMENTO

Tre post sul tetto. Poi è arrivata la manovra.

Ho chiesto a tre AI di rifarla.

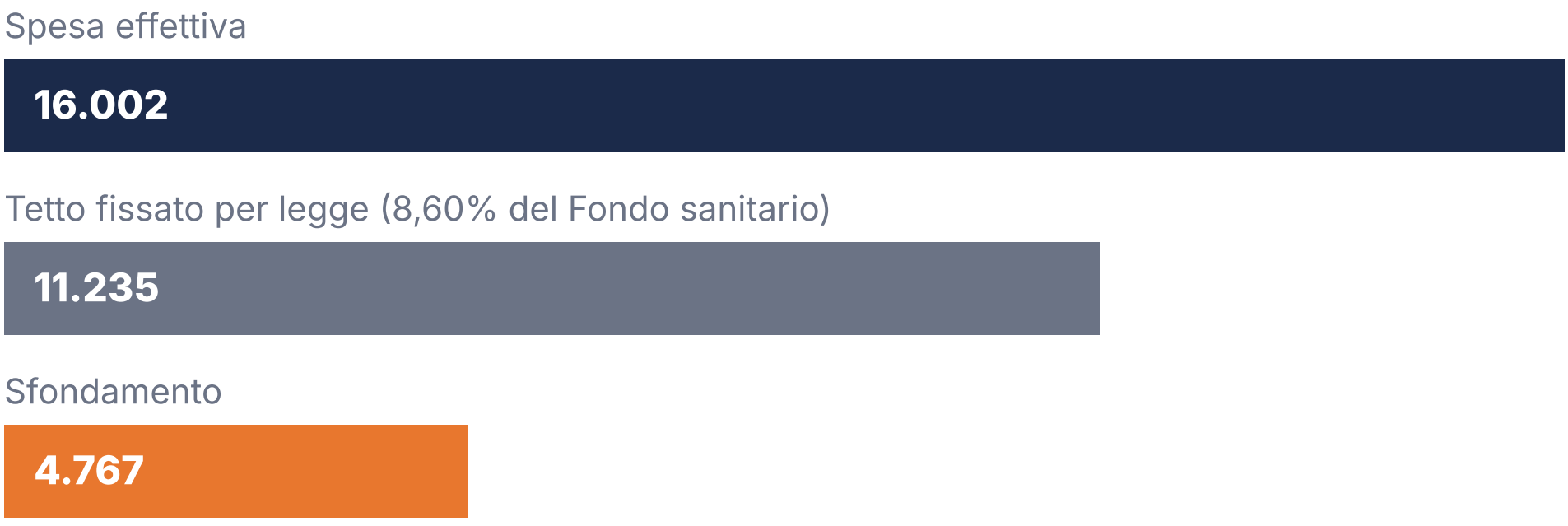
Stessi documenti, stessi soldi del Governo, non un euro in più.

Cosa avreste fatto?

Tre risposte diverse. Un punto in comune. E un'idea che avevo già scritto il 20 ottobre.

I farmaci di ospedali e ASL costano più di quanto la legge ha deciso di spendere.

Milioni di euro, 2025.



½ **Metà la restituiscono le aziende.** Si chiama payback: nel 2025 vale circa 2,4 miliardi.

½ **L'altra metà la pagano le Regioni.**

Succede da nove anni su nove. Nei post di ottobre ho proposto di fissare il tetto partendo dalla spesa vera.

Fonte: AIFA, monitoraggio della spesa farmaceutica gennaio-dicembre 2025 (consuntivo). Acquisti diretti esclusi i gas medicinali.

Tre misure sul farmaco. 522 milioni l'anno a regime.

DDL bilancio 2027 (A.C. 3174), presentato il 30 ottobre 2026. Milioni di euro l'anno.

292
dal 2028 · art. 71, c. 1

Alza il tetto di 0,2 punti

È il 6% dello sfondamento. Metà sono payback che le aziende non restituiranno più, metà un sollievo per le Regioni.

160
dal 2027 · art. 71, c. 2-8

Sconto a chi investe in Italia

Le aziende con investimenti aggiuntivi pagano meno payback. Lo Stato rimborsa alle Regioni la parte mancante. Vale già per il 2026.

70
2027-2029 · art. 72

Accesso precoce

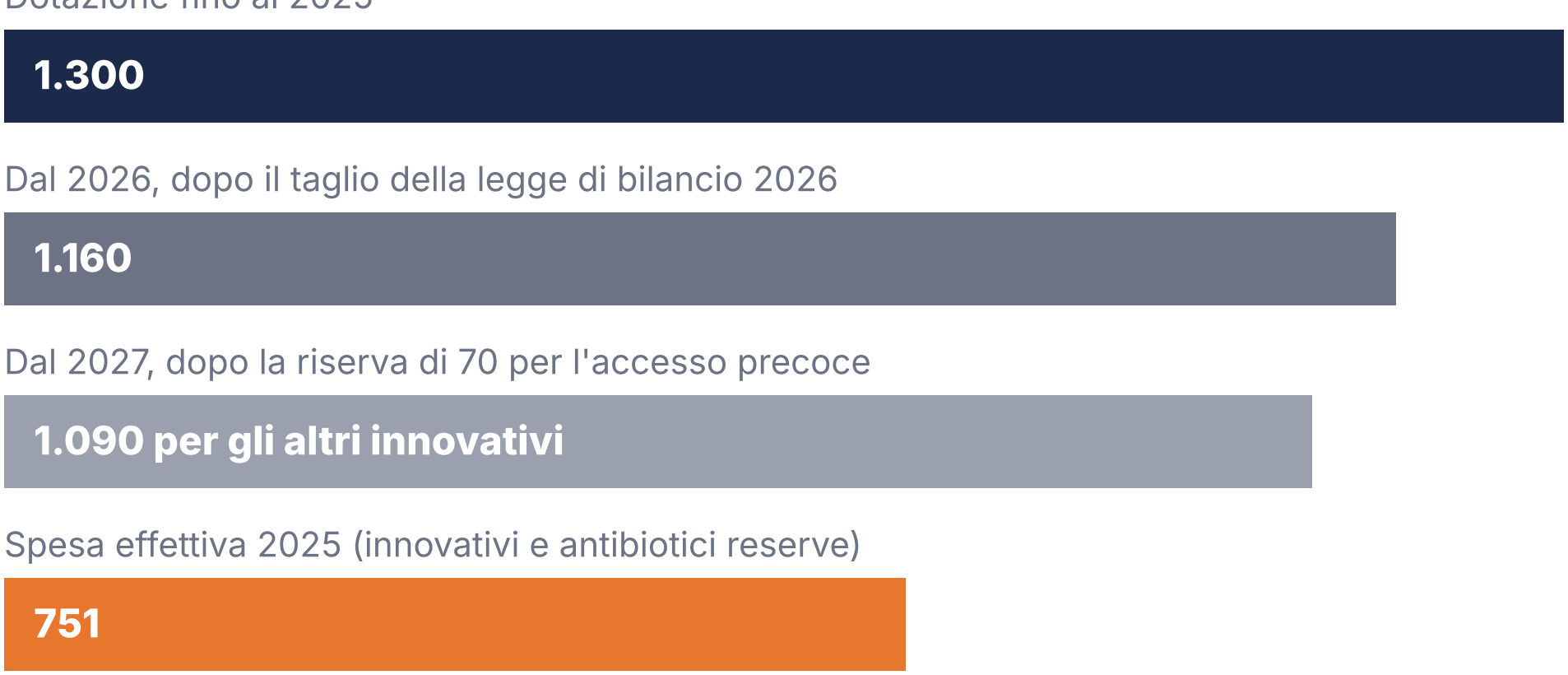
Farmaci per malattie gravi senza alternative, ai pazienti prima che AIFA decida sul rimborso. Non sono soldi nuovi: vengono dal fondo per i farmaci innovativi.

Dei 522 milioni, 306 vanno alle aziende. Il tetto si avvicina alla spesa vera di 0,2 punti.

Fonte: A.C. 3174, Tomo I (relazione tecnica, pp. 316-318) e Tomo II (artt. 71-72). Esclusi i dispositivi medici (art. 73).

Il fondo per i farmaci innovativi: tutti ci attingono.

Milioni di euro l'anno. Dotazione per legge e spesa effettiva.



Un fondo che non si spende tutto e da cui si prende per tutto. Forse vale la pena cambiargli nome.

Fonti: L. 199/2025, c. 388 (taglio di 140); A.C. 3174, art. 72 (riserva di 70 sui commi 288 e 290); AIFA, consuntivo 2025, spesa innovativi e reserve al netto dei payback.

Stessi documenti, stessi soldi, tre AI.

Lo stesso prompt a ChatGPT, Gemini e Claude, il 5 novembre 2026.

1. **Stesse fonti.** Il DDL con le relazioni, la legge di bilancio 2026, i monitoraggi AIFA, i rapporti OsMed. Una cartella condivisa, niente internet.

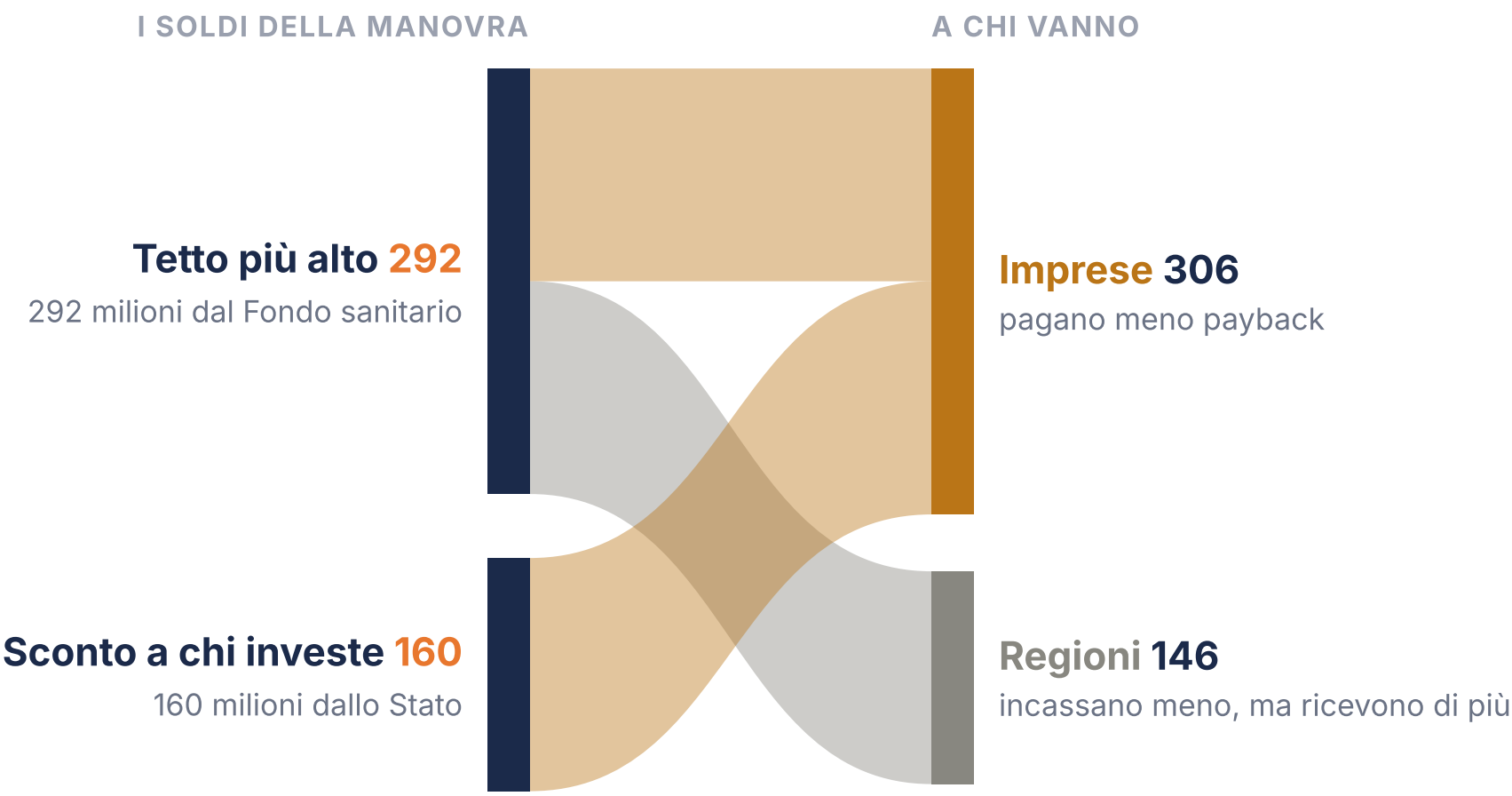
2. **Stesso vincolo.** Potevano cancellare, cambiare o sostituire le tre misure. Il totale doveva restare quello: 160 milioni nel 2027, 452 dal 2028, più i 70 già nel fondo.

3. **Stesse domande.** Giudicare le misure, proporre la propria manovra con i conti, dire chi ci guadagna e chi paga, dichiarare i criteri.

La prima mossa è uguale per tutte e tre: via lo sconto a chi investe. Lo giudicano politica industriale, non sanitaria.

Il Governo: 306 su 522 alle aziende.

Milioni di euro l'anno a regime (2028-2029). Stessa scala nelle quattro slide.





IN SINTESI

Due misure su tre riducono il payback delle aziende. L'unica misura per i pazienti, l'accesso precoce, è pagata togliendo soldi ad altri farmaci innovativi.

ChatGPT il riformista prudente

Tiene il tetto, cancella lo sconto, finanzia i pazienti.

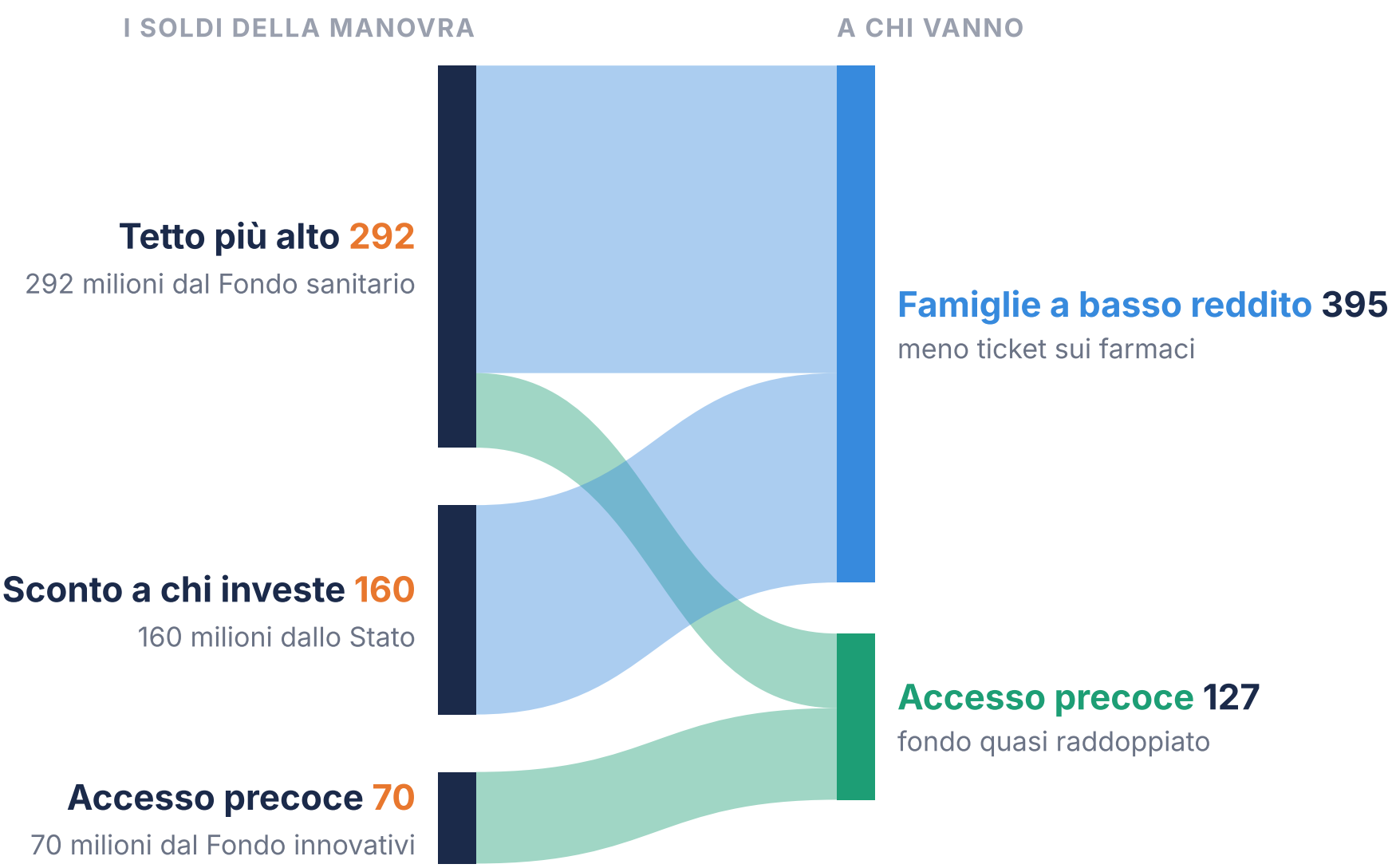


PERCHÉ

Lo sfondamento è reale, quindi il tetto più alto resta. Lo sconto a chi investe "premia spese già decise": i 160 vanno ad accesso precoce con soldi veri, servizi ai pazienti fragili e dati per valutare. Il fondo innovativi non si tocca.

Gemini il radicale

Alle aziende niente. Tutto a famiglie e pazienti.



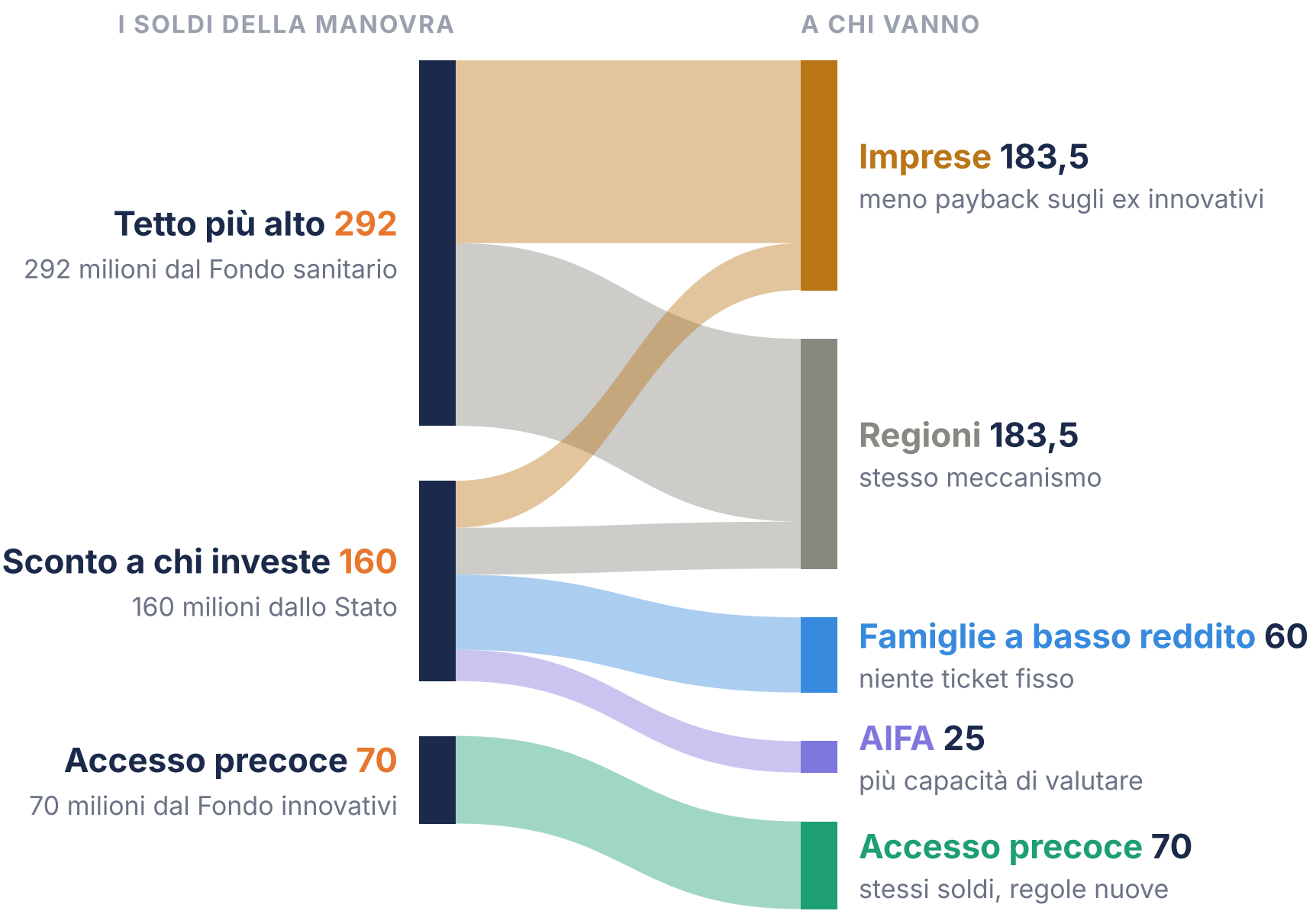
PERCHÉ

I soldi della sanità devono "produrre salute o abbattere barriere economiche", non fare da ammortizzatore all'industria. Cancella tetto più alto e sconto, e usa i 452 per togliere il ticket sui farmaci alle famiglie a basso reddito e allargare l'accesso precoce.

Cifre del 2028. La misura sul ticket, così come è scritta, esenta chi sceglie l'equivalente, che la differenza di prezzo già non la paga: il costo reale sarebbe molto più basso.

Claude il tecnico

Stesso sollievo alle aziende, ma legato al valore dei farmaci.



PERCHÉ

Al posto del tetto più alto, un fondo per i farmaci che hanno appena perso l'innovatività e finiscono di colpo nello sfondamento. Il payback cala come nel DDL, ma solo per prodotti con beneficio dimostrato. Lo sconto sparisce: 60 alle famiglie, 25 ad AIFA, e l'accesso precoce cambia regole.

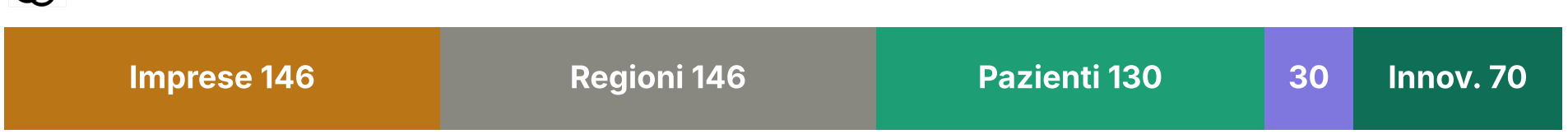
Chi riceve i 522 milioni, a seconda di chi decide.

Milioni di euro l'anno a regime. Per Gemini, cifre del 2028. Conti rifatti dall'autore.

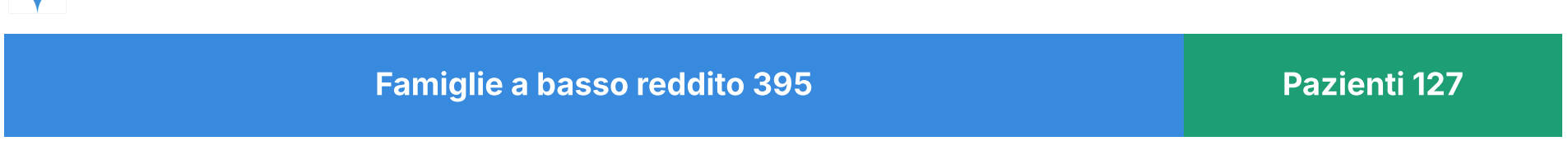
Governo



ChatGPT



Gemini



Claude



Imprese (meno payback) · Regioni · Famiglie a basso reddito · Pazienti (accesso precoce e servizi) · Valutazione e capacità AIFA · Fondo innovativi preservato

E per il dopo 2029 una delle tre propone un tetto che si riallinea alla spesa vera, un po' per anno. La stessa idea del post del 20 ottobre.

Potenziare l'Agenzia, tenere le risorse nel farmaceutico.

Le sfide dei prossimi anni non si governano a colpi di 0,2 punti.

Terapie da milioni di euro a paziente
geniche e cellulari, già in arrivo

Valutazione clinica europea congiunta
partita nel 2025 per oncologici e terapie avanzate

Brevetti dei grandi biologici in scadenza
risorse da liberare, se si programma

Farmaci per l'obesità
una platea che cambia la scala della spesa

Prezzi americani che arrivano in Europa
la clausola della nazione più favorita

Un tetto lontano dalla spesa vera
da nove anni su nove

Toccano tutti insieme: aziende, Regioni, AIFA, pazienti.

TRE COSE DA PORTARE A CASA

1. **La manovra alleggerisce il payback, non programma.** 306 milioni su 522 alle aziende; il tetto si avvicina alla spesa vera del 6%.

2. **Con gli stessi soldi, tre AI avrebbero fatto altro.** Tutte tolgono lo sconto a chi investe: politica industriale, non sanitaria. Due su tre finanziano chi deve valutare.

3. **Divisi ne usciamo solo con le ossa rotte.** Le sfide in arrivo toccano aziende, Regioni, AIFA e pazienti insieme.

Testo, immagini e conti sono dell'autore. Le proposte delle AI sono riportate così come generate.

Nota di metodo. Proposte generate il 5 novembre 2026 da ChatGPT, Gemini e Claude con lo stesso prompt e la stessa cartella di documenti (DDL A.C. 3174 con relazioni, L. 199/2025, monitoraggi AIFA, OsMed). Conti verificati e immagini realizzate dall'autore con il supporto di Claude, che è anche uno dei tre modelli valutati; i limiti della sua proposta sono segnalati come quelli delle altre. Fondo innovativi: spesa 2025 per innovativi e reserve al netto dei payback, AIFA consuntivo 2025. I loghi appartengono ai rispettivi titolari e sono usati a scopo identificativo.